4.2.7.雙特異性單株抗體藥物(如 emicizumab)：(108/11/1、109/8/1、109/12/1、112/7/1、113/7/1、115/3/1、115/8/1、115/11/1)

限用於 A 型血友病且有抗體病人及嚴重(FVIII 小於 1%)未帶有抗體 A 型血友病病人之預防性治療：

1.用於 A 型血友病且有抗體病人預防性治療，並符合以下情形：

(1) 經 Bethesda 分析法不只一次證實帶有第八凝血因子抑制性抗體≥5.0BU。(108/11/1、109/8/1)

(2)使用 emicizumab 24 小時以前繞徑藥物須停止使用。病人領取的 Feiba 必須先使用完後，才能考慮開始使用 Hemlibra。(108/11/1、109/8/1)

(3) 若發生突破性出血時，第一線藥物為 rVIIa 或第八凝血因子；除非沒有其他選擇，儘量避免使用 Feiba。

I. 用 rVIIa，需要從低劑量(45-90 μg/kg)開始使用，不可以使用高劑量。

II.用 Feiba，第一次使用不可超過 50IU/Kg；需第二劑使用時，一天內不得超過 100IU/Kg。

2.用於嚴重(FVIII 小於 1%)未帶有抗體 A 型血友病病人之預防性治療。(112/7/1、115/3/1)

3.皮下注射預防性治療(prophylaxis)：最初 4 週，每週一次投予 3 mg/kg(負荷劑量)，之後改為每週一次投予 1.5 mg/kg、每 2 週一次 3 mg/kg 或每 4 週一次 6 mg/kg（維持劑量)。(108/11/1、109/8/1)

4.初次使用需經事前審查後核准後使用。(108/11/1、109/8/1、112/7/1、115/3/1)

5.門診之血友病病人得攜回一至二劑量(至多攜回一個月)備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之六—全民健康保險血友病患者使用雙特異性單株抗體藥物在家治療紀錄表)及登錄醫療評估追蹤紀錄表(附表十八之五)：(109/8/1、109/12/1)

(1)每 1 週皮下注射一次者，可攜回二次劑量。

(2)每 2 週皮下注射一次者，可攜回一次劑量。

(3)每 4 週皮下注射一次者，則每 4 週均回醫院領藥注射並觀察追蹤。

6.不得與第八凝血因子製劑、fitusiran 及 concizumab 併用。(113/7/1、115/8/1、115/11/1)